

Université de Constantine 2025
Faculté de médecine

Sémiologie de l'appareil génital

Cours de sémiologie

3ème année de médecine

Dr.A.Boudjeriou

boudjeriou.amira@gmail.c

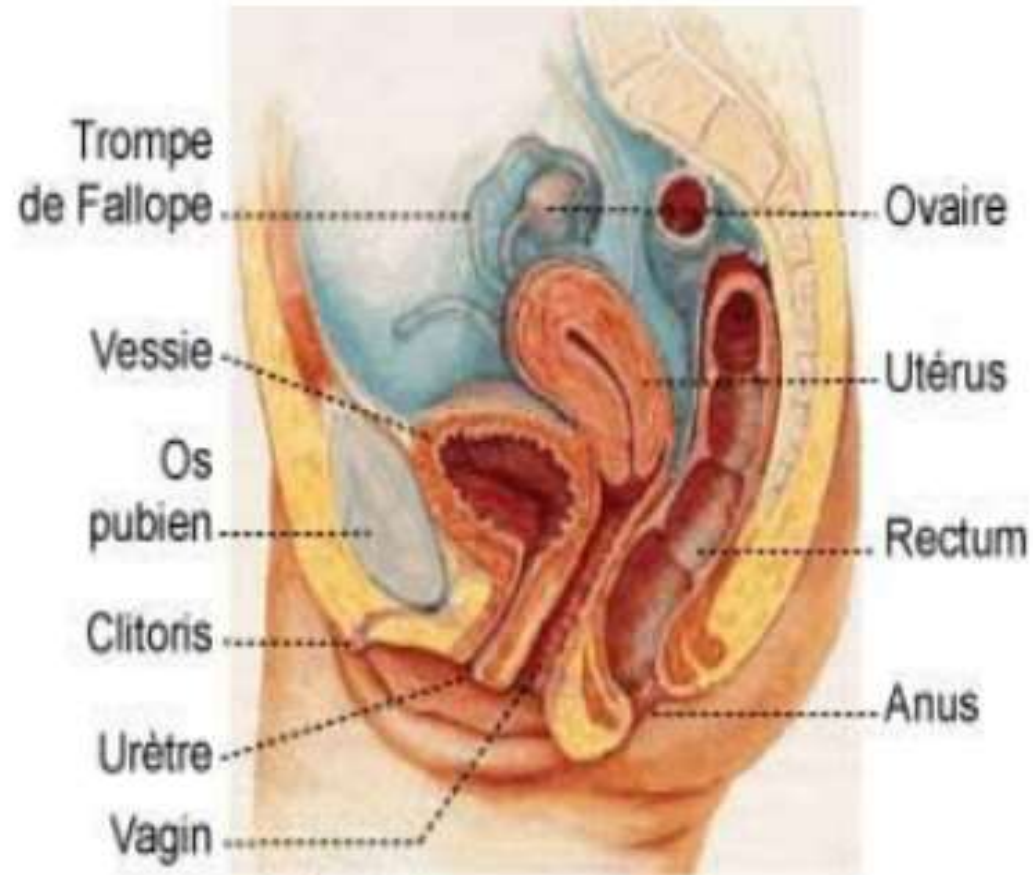
Plan :

- ▶ 1) Rappel anatomique
- ▶ 2) Rappel physiologique
- ▶ 3) Etude sémiologique :
 - ▶ A/ interrogatoire
 - ▶ B) 'examen gynécologique

Objectifs :

- ▶ Connaitre les principaux signes cliniques
- ▶ Faire un examen clinique minutieux
- ▶ Orienter les explorations selon la probabilité clinique

1 / Rappel anatomique



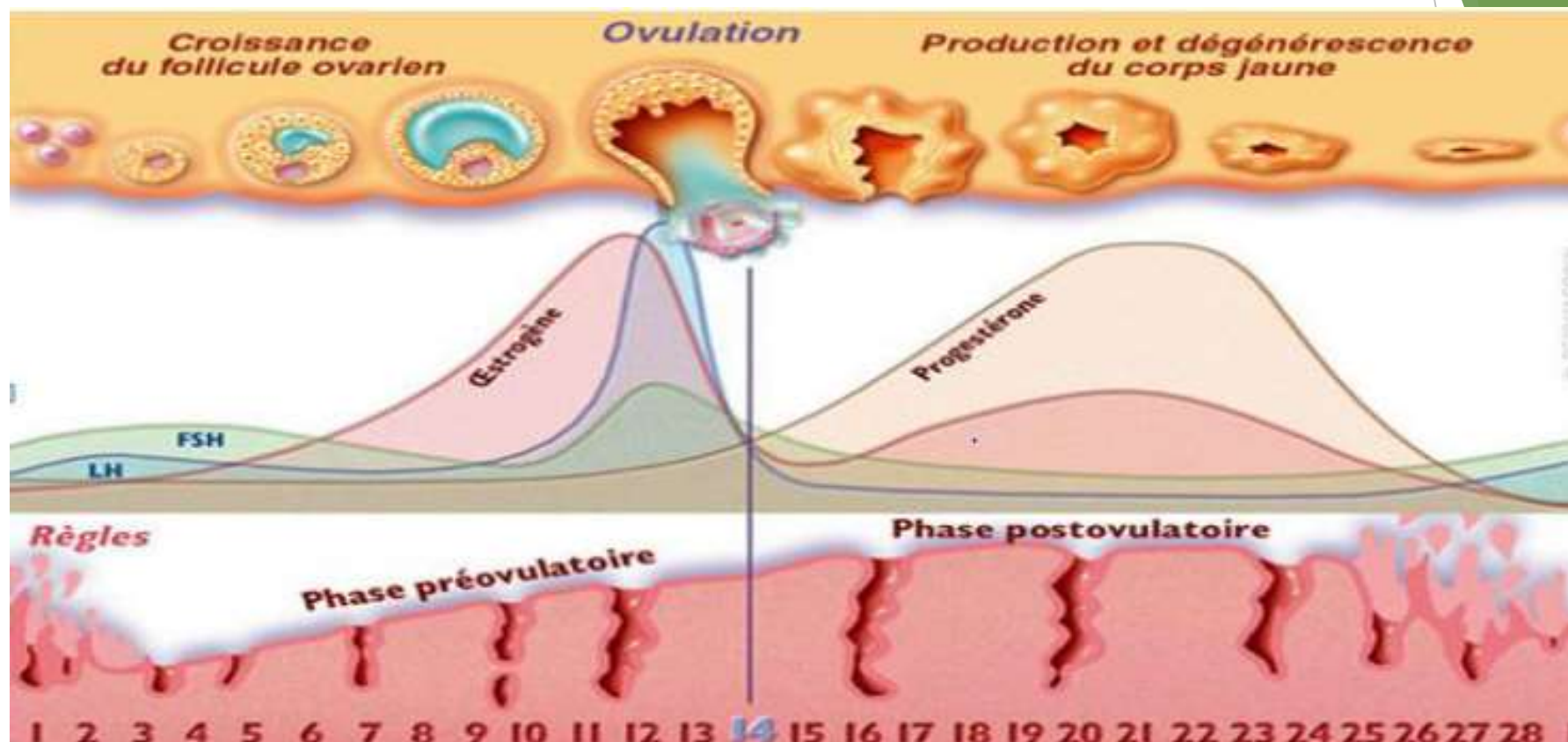
2/Rappel physiologique

► Puberté:

- Premier signe: développement mammaire (10-11ans)
- 1ere menstruation: 2 ans plus tard
- Pilosité pubienne et axillaire se complètent en 2 à 3ans

► Cycle menstruel

- Un cycle normal est de 28- 30j, se terminant par une menstruation (50 ml) de durée moyenne de 4-6j
- Menstruation: élimination de la muqueuse de l'endomètre s'accompagnant d'une hémorragie



2/Rappel physiologique

► Le cycle menstruel comporte 4 phases:

1- Pré ovulatoire: du 5 -14ème j , ou phase proliférative, elle est sous la dépendance des œstrogènes.

- Ovulatoire:14-16ème j, elle est favorisée par une décharge brutale de LH

3- Post ovulatoire:17-28ème j, ou phase sécrétoire, elle est sous la dépendance des œstrogènes et progestérones

4-Menstruation: 1er - 5ème j

2/Rappel physiologique

► Courbe de température:

- L'élévation de la température(37,2° c) signale La phase ovulatoire
- Hormones ovariennes: sous la dépendance de stimulines

Antéhypophysaire FSH, LH

3 / Etude sémiologique

Repose sur l'interrogatoire et l'examen gynécologique

A- Interrogatoire:

✓ Antécédents physiologiques : la vie génitale dès les premières règles jusqu'à la ménopause:

- **Ménarchie**: date des premières règles (10-16ans)

- **Cycle menstruel**

 - . Rythme (tous les 28-30j)

 - . La durée(3-6j)

 - . L'abondance(nombre de garniture/j)

 - . La date des dernières règles afin de dépister un début de grossesse

3/Etude sémiologique

- Nombre de grossesses et d'accouchement
- Nombre d'enfants vivants et décédés
- Rechercher la notion d'avortement et d'accouchement prématuré
- Notion de contraception

- Ménopause:

Disparition définitive des règles en rapport avec l'arrêt de la fonction cyclique des ovaires.

- Age de survenue: 40-50 ans, d'où: - ménopause précoce
 - ménopause tardive

3 / Etude sémiologique

- ✓ Antécédents pathologiques:
 - ▶ Hystérectomie
 - ▶ intervention pour kyste de l'ovaire
 - ▶ césarienne
 - ▶ des antécédents d'infection génitale,
 - ▶ Tuberculose
 - ▶ néoplasie (cancer du sein ou du col...).

3/Etude sémiologique

Douleurs

- Pelviennes siégeant au niveau de l'hypogastre et des fosses iliaques
- Association des douleurs lombaires ++
- Dyspareunie:
 - Douleurs ressentie au niveau du vagin ou du petit bassin lors des rapports sexuels, elle peut être fonctionnelle ou révélant une affection chronique

3 / Etude sémiologique

Pertes vaginales

Pertes blanches, fréquentes, mais peuvent prendre d'autres couleurs:

- 1- **Blanchâtres caillottées:** abondantes, un prurit intense avec à l'examen une rougeur vulvaire et vaginale, elles sont en rapport avec une mycose, et se voient dans les états d'immunodépression (grossesse, diabète, anxiété)
- 2- **Blanc jaunâtres:** plus fluide, odorantes, s'accompagnant de prurit et de brûlures vulvaires, elles sont dues au trichomonas vaginalis

3- Franchement purulentes:

Jaunâtres ou verdâtres, pas de prurit, ni sensation de brûlure,
une infection est à évoquer au niveau du Col

4- Transparente:

Visqueuse, filante et sans odeur, ce sont des sécrétions génitales physiologiques qui surviennent 2-3j avant l'ovulation

3/Etude sémiologique

Hémorragies génitales

Deux types extériorisées et non extériorisées

- **Extériorisées**: pertes sanglantes de trois types selon leurs dates de survenue par rapport aux règles:

1-Ménorragie: règles trop abondantes ou trop prolongées, recherche systématique d'un fibrome utérin

2-Métrorragies: pertes sanglantes en dehors des règles, spontanées ou provoquées, d'aspect variable soit faites de sang rouge ou de caillots noirâtres, un cancer génital doit être recherché

3-Ménométrorragies: association des deux types précédents

3/Etude sémiologique

Hémorragies génitales

- **Non extériorisée:**
- Rupture de la grossesse extra utérine:
 - . Urgence chirurgicale+++
 - . Nidation de l'œuf fécondé en dehors de la cavité utérine (au niveau des trompes)
 - . Responsable d'une déchirure de cette trompe, et ainsi d'un hémopéritoine avec tableau clinique d'hémorragie interne grave

► Interrogatoire:

- Retard des règles
- Petit saignement noirâtre
- Douleurs pelviennes latérales

► Examen clinique:

- Sensibilité hypogastrique
- Cri de Douglas
- Signes de grossesse

Troubles de la menstruation

- Ménorragies
- Pollaki-menorrhée: règles trop rapprochées
- Spanio-menorrhée: règles trop espacées
- Oligo-menorrhée: règles trop courtes
- Oligospanio-menorrhée: règles trop courtes et trop espacées

Troubles de la menstruation

► Aménorrhée:

Disparition des règles durant la vie génitale active, elle peut être primaire ou secondaire:

- . Primaire: absence de ménarchie
- . Secondaire: a une grossesse ou a des causes pathologiques (tuberculose, curetage , hystérectomie).

► Dysménorrhées:

Douleurs accompagnant les règles mais peuvent les précéder de quelques jours

B- Examen gynécologique :

Les conditions de l'examen :

Plusieurs conditions doivent être réunies

- Chambre bien éclairée, bien chauffée, bien aérée
- Malade a vessie et rectum vidé
- Décubitus dorsal
- Les cuisses demi fléchis en abduction, jambes fléchis
- Table gynécologique
- Speculum
- Doigtier a deux doigts
- Lubrifiant

1





B- Examen gynécologique :

Conduite de l'examen :

Inspection:

Appréciation des caractères sexuels secondaires:

- . Seins
- . Pilosité axillaire
- . Pilosité pubienne : triangulaire
- . Organes génitaux externes

B- Examen gynécologique :

Conduite de l'examen :

Palpation:

Recherche de zones sensibles et douloureuses au niveau des fosses iliaques ou de la région sus pubienne qui peut révéler l'existence d'une tumeur abdomino-pelvienne

Percussion:

Elle permet de différencier un volumineux kyste de l'ovaire a développement abdominal d'une ascite

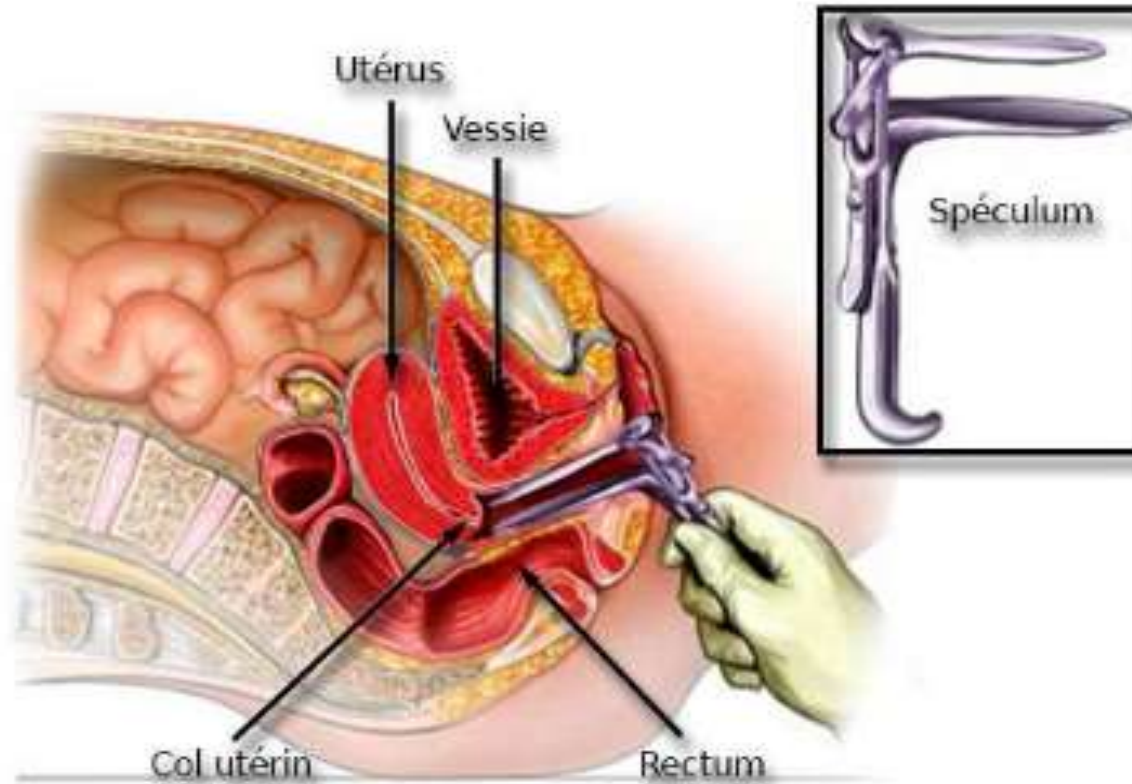
B- Examen gynécologique :

Examen au speculum:

Précède toujours le toucher vaginal

- Apprécie l'aspect du col de l'utérus:
 - . Situation central ou déviée latéralement
 - . Forme : *Conique chez la primipare
 - *Cylindrique chez la multipare
 - *Atrophique chez la ménopausée
 - . Orifice externe: *Lésion traumatique, *Erosion , tumeurs proliférantes
- Permet également d'effectuer des frottis vaginaux, et colposcopie, biopsie du Col

Examen Au Spéculum





A: zone rouge ulcérée



B: zone rouge de surface irrégulière



C: zone rouge érosive

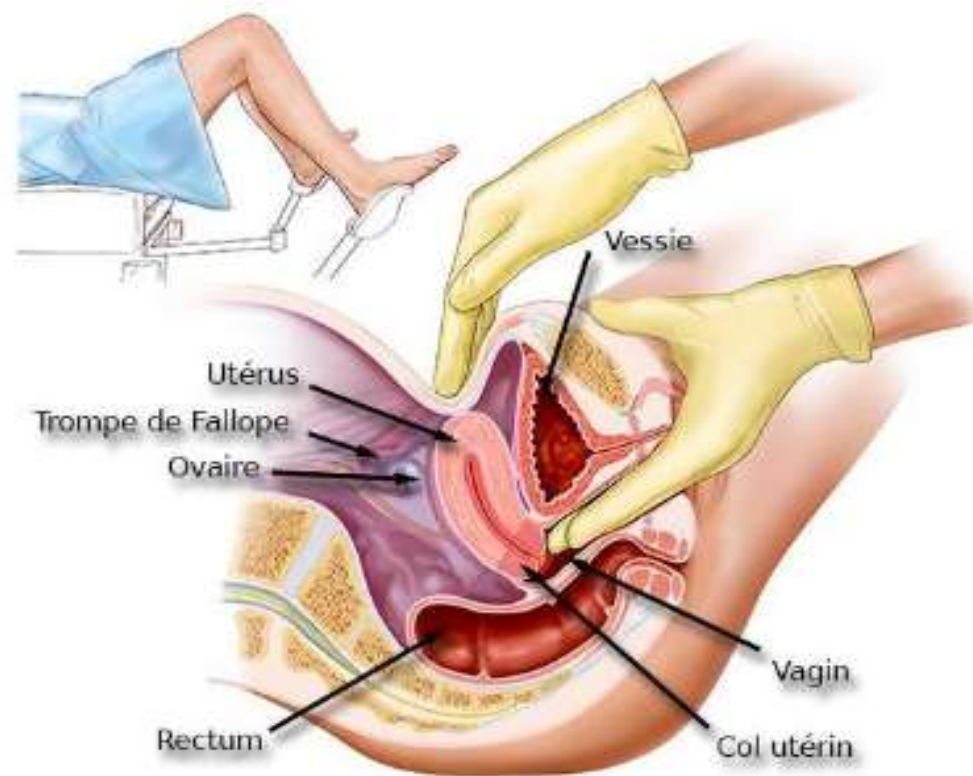
B- Examen gynécologique :

Toucher vaginal:

Se fait avec le doigtier stérile a deux doigts (index+ majeur) en utilisant un l
lubrifiant appréciant ainsi

- Etat du Col
- Situation et consistance: normalement souple , ferme et élastique, mou chez la femme enceinte
- Etat des culs de sac vaginaux: souplesse et vacuité

Toucher Vaginal



B- Examen gynécologique :

TV Combiné au palper abdominal:

- Apprécier l'utérus:
 - . Siège
 - . Volume
 - . consistance et sensibilité
- Explorer les annexes

TV+TR:

- Appréciation de l'état de la cloison recto vaginale
- Apprécier l'aspect du doigtier: propre , sang ou leucorrhées
- **Chez la jeune fille, le toucher rectal remplace le toucher vaginal.